

PROTOCOLO DE PIELONEFRITIS AGUDA

Unidad de Observación de Urgencias (UOME)

1. OBJETIVO

Manejo protocolizado de pacientes diagnosticados en Urgencias de pielonefritis aguda no complicada, subsidiarios de observación clínica, antibioterapia intravenosa inicial y alta precoz (<36 h), evitando ingresos convencionales innecesarios y garantizando seguridad clínica y adecuación antibiótica.

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DESDE URGENCIAS A UOME

Pacientes con diagnóstico clínico-radiológico de pielonefritis aguda no complicada (mujer premenopáusica, no gestante, inmunocompetente, sin alteraciones estructurales conocidas de la vía urinaria y sin criterios de sepsis), que precisen:

- Control evolutivo, reevaluación clínica y/o analítica.
- Hidratación y analgesia.
- Inicio o continuación de antibioterapia IV.
- Observación por intolerancia oral transitoria o fiebre persistente inicial.

Condiciones mínimas:

- TAS ≥ 100 mmHg, sin necesidad de vasopresores.
- FC <120 lpm sin fiebre.
- SatO₂ >92% basal.
- Previsible estabilidad hemodinámica y alta en ≤ 36 h.

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN / INGRESO DIRECTO HOSPITALARIO

Complicación urológica: ingresa en UROLOGIA

- Varón
- Obstrucción urinaria: litiasis obstructiva, tumores uroteliales obstructivos
- Hidronefrosis infectada. Absceso renal/perinéfrico
- Trasplante renal /Monorreno
- Dispositivos de derivación urinaria (nefrostomía, doble J, Bricker)

Pielonefritis complicada por causa no urológica: ingresa en MI

- Sepsis sin complicación urológica
- Embarazo
- Neutropenia, inmunosupresión grave
- ERC estadio IV–V
- Fragilidad severa o dependencia importante
- Imposibilidad de seguimiento

4. EVALUACIÓN INICIAL EN UOME

Constantes al ingreso:

- TA, FC, FR, SatO₂ y temperatura.
- Valoración de diuresis si precisa.

Análítica obligatoria:

- Hemograma.
- Bioquímica con función renal e iones, PCR
- Sedimento urinario.
- Urocultivo antes de antibioterapia empírica si no se realizó previamente.

Según gravedad:

- Lactato.
- Procalcitonina.
- Hemocultivos si fiebre >38,5°C o inmunosupresión

5. CONTROL EVOLUTIVO EN UOME

Control de constantes:

Primeras 12 horas:

- Cada 4 horas: FC, T^a, TA

Posteriormente:

- Cada 6–8 horas si estabilidad clínica

Reevaluación médica:

- A las 6–8 h:
 - dolor
 - respuesta térmica
 - tolerancia oral
 - estabilidad hemodinámica

- A las 24 h:

- reevaluación clínica global

- necesidad de pruebas de imagen (ecografía /TC) si no se realizaron en urgencias.
- valoración de alta, HAD o ingreso en planta

6. CONTROL ANALÍTICO

Realizar control analítico evolutivo habitualmente a las 12–18 h

7. PRUEBAS DE IMAGEN

Ecografía renal:

Realizar en primeras 24 h si sospecha de pielonefritis complicada:

- Varón.
- Antecedente de nefrolitiasis o sospecha obstructiva.
- Enfermedad renal aguda.
- Dolor unilateral intenso.
- Mala evolución clínica.
- Recurrencias.
- Diabetes o inmunosupresión.

No obligatoria en:

- Mujer joven.
- Buena respuesta clínica.
- Función renal normal.
- Sin antecedentes urológicos.

TC abdominopélvico urgente si:

- Sepsis
- Persistencia fiebre >48 h de tratamiento antibiótico adecuado
- Sospecha de absceso, descartar focos de nefritis.

8. TRATAMIENTO EN UOME

Hidratación:

- SF 0,9% 500–1000 ml iniciales según situación clínica.
- Posteriormente sueroterapia habitual de dieta absoluta según necesidad, tolerancia y comorbilidad.

Analgesia escalonada y antitérmicos:

- Paracetamol 1 g IV cada 8 h.
- Metamizol 2 g IV cada 8 h si precisa por dolor.
- Dexketoprofeno 50 mg IV cada 8 h si no contraindicación.
- Valorar opiáceos IV si dolor refractario.

9. ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA (alineada con criterios PROA)

SIEMPRE tras extracción de urocultivo si no retrasa el inicio terapéutico.

SIN FACTORES DE RIESGO DE MULTIRRESISTENCIAS:

- Ceftriaxona 2 g IV cada 24 h (primera elección recomendada). Dosis única si es pielonefritis no complicada.

Alternativa:

- Amoxicilina-clavulánico 1 g IV cada 8 h.

CON FACTORES DE RIESGO DE MULTIRRESISTENCIAS (BLEE Y PSEUDOMONAS): BLEE previo, Antibioterapia últimos 90 días, ingreso reciente, institucionalización, sondaje urinario, manipulación urológica reciente.

- Piperacilina-tazobactam 4,5 g IV cada 6–8 h
- Meropenem 1 g IV cada 8h / Ertapenem 1 g IV cada 24 h

Alergia a betalactámicos:

- Aztreonam 1 g IV cada 8 h ó Amikacina 20 mg/kg cada 24 h (previa a antibiograma)

10. DESTINO EVOLUTIVO

ALTA DOMICILIARIA:

- Mejoría clínica. Estabilidad hemodinámica
- Tolerancia oral adecuada
- Dolor controlado

- Función renal estable. Sin sospecha obstructiva
- Plan antibiótico definido
- Apoyo sociofamiliar adecuado

HOSPITALIZACION A DOMICILIO (HAD):

Considerar si:

- Precisa continuar antibioterapia IV (ertapenem, ceftriaxona)
- Mejoría parcial favorable y estabilidad hemodinámica
- Necesidad de vigilancia clínica o analítica
- Apoyo familiar adecuado y residencia en área geográfica incluida

INGRESO HOSPITALARIO:

- Mala evolución
- Sepsis/Shock séptico
- Complicación urológica
- Intolerancia oral persistente
- Empeoramiento renal o hemodinámico

11. ANTIBIOTERAPIA ORAL AL ALTA

Empírica o según antibiograma si está disponible:

- Cefixima 400 mg VO cada 12 h DE ELECCIÓN
- Cefditoreno 400 mg VO cada 12 h
- Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg VO cada 8 h
- Ciprofloxacino 500–750 mg VO cada 12 h: reservar a sensibilidad demostrada o situaciones justificadas (ANAFILAXIA A BETALACTÁMICOS)

Duración total:

- 7 días en formas no complicadas con buena evolución
- 10–14 días en pielonefritis complicadas

12. GESTIÓN DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS PENDIENTES

La ausencia de resultado definitivo del urocultivo no contraindica el alta desde UOME si existe evolución clínica favorable.

Pendiente de concretar circuito organizativo:

- contacto directo PROA-paciente
- o aviso a UOME/facultativo responsable ante discordancia terapéutica relevante

Actuar especialmente si microorganismo multirresistente

13. RECOMENDACIONES AL ALTA

Explicar signos de alarma:

- fiebre persistente >48 h
- vómitos
- empeoramiento del dolor
- oliguria
- deterioro general

Recomendaciones:

- completar antibioterapia
- adecuada hidratación oral
- evitar AINEs prolongados si deterioro renal

Seguimiento:

- revisión de urocultivo en 48–72 h en Centro de Salud/PROA
- ajuste antibiótico según antibiograma
- seguimiento por MAP/Urología según factores de riesgo

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON:

PIELONEFRITIS

En un paciente con PIELONEFRITIS en una unidad de observación se debe vigilar los signos y síntomas de posibles complicaciones (SEPSIS)

Signos y síntomas a vigilar y registrar

- **Constantes vitales y estado general**
 - Fiebre: $>38^{\circ}\text{C}$ o picos de escalofríos/temblores o hipotermia $<36^{\circ}\text{C}$
 - FC: Taquicardia $>90\text{-}100$ lpm sin dolor/ansiedad. Primer signo de sepsis.
 - TA: Vigila hipotensión $<90/60$ o bajada de 40 mmHg de su basal. Riesgo de shock séptico.
 - FR: Taquipnea >22 rpm = criterio qSOFA positivo.
 - Estado mental: Confusión, agitación o somnolencia. En >65 años es el signo de sepsis más precoz.
- **Signos urinarios y renales**
 - Dolor: Costo-vertebral agudo, unilateral. "Puño-percusión renal positiva"
 - Síntomas miccionales: Disuria, polaquiuria, urgencia, orina turbia/maloliente.
 - Diuresis: Oliguria <0.5 ml/kg/h en 6h. La pielonefritis puede dar fallo renal agudo.
 - Color orina: Hematuria visible, muy oscura o muy concentrada por deshidratación.
- **Sueroterapia y balance hídrico:**

- Vigilancia de diuresis

Signos digestivos y sistémicos

- Nauseas /vómitos (muy frecuentes que puedan provocar deshidratación). Vigilar tolerancia oral.
- Dolor abdominal: suele localizarse más bien en zona lumbar o flanco
- Malestar general intenso: paciente decaído, no quiere moverse.

Signos de alarma

Avisar de inmediato si aparecen:

Anuria o diuresis <200ml/6h

Vómitos que no ceden y no tolera antibiótico oral

Dolor renal que aumenta pese a analgesia IV.

Datos de sepsis:

- fiebre persistente,
- taquicardia,
- hipotensión,
- alteración mental.

BIBLIOGRAFÍA:

1. - Ferrer Tarrés JM, Prat Marín A, Tomás Vecina S. Revisión de la utilización de las áreas de observación de urgencias hospitalarias. Med Clin (Barc). 2007;128(6):224-31. Quirónsalud.
2. - Inhaladores de cartucho presurizado: técnica de inhalación. Escuela de Pacientes Neumología. Madrid: Quirónsalud; 2023. Disponible en: <https://www.quironsalud.com> [Acceso 04 sept 2026]. Servicio Andaluz de Salud.
3. - Guía de diseño y organización de servicios de urgencias hospitalarias. Sevilla: Consejería de Salud; 2016.Soler Gómez Y, Fernández Viñado DM, Martínez Fernández C, et al.
4. - Atención de enfermería al paciente politraumatizado por accidente de tráfico: enfoque integral en la emergencia. Rev Sanitaria Invest. 2025;6(7):e2660-7085.Sánchez Reyes E, Pinal Moreno E, Ortega Vargas MC.
5. - Guía clínica de enfermería del enfermo con insuficiencia cardíaca. Rev Enferm IMSS. 2004;12(3):155-62. Grupo de Trabajo de EPOC SEMERGEN.
6. - Protocolo de manejo del paciente con EPOC agudizado en urgencias. SEMERGEN. 2020;46(Supl 1):1-12. Gómez Martínez A, González Vallejo ML, García Cuesta P.
7. - Plan de cuidados enfermeros en el paciente con EPOC y neumonía según taxonomía NANDA-NIC-NOC. Rev Enferm CyL. 2018;10(2):45-58. Gobierno de Canarias.
8. - Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos: Traumatismos II. Las Palmas: Consejería de Educación; 2021.Universidad de Salamanca.
9. - Guía docente Enfermería en Urgencia y Riesgo Vital. Grado en Enfermería. Ávila: USAL; 2024-2025.Mayo Clinic.

10. - Inhaladores para el asma: ¿cuál es el indicado para usted? Rochester: Mayo Foundation; 2024. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org> [Acceso 04 sept 2026].
11. - Guía de actuación en urgencias de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)
12. - Cuidados de enfermería en el paciente crítico en urgencias de García González, M., et al. (2020)
13. - Manejo del paciente con dolor torácico en urgencias de López López, J., et al. (2019)
14. - Emergencias (revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)
15. - Enfermería de Urgencias (revista especializada en cuidados de enfermería en urgencias)
16. - SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) - Guías y protocolos
17. - SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias) - Recursos y documentos